

a8_escalation_decision 测试报告

生成时间：2026-05-08 20:16:06

测试时间：2026-05-08 20:16:06

- 一、测试目的：验证工具增强对输出质量提升作用。
- 二、测试内容：同一输入下，分别运行 use_tools=True/False。
- 三、测试方法：对比输出结构与长度，核对产物路径。
- 四、测试过程：
 - 1) 启用工具运行；
 - 2) 禁用工具运行；
 - 3) 指标对照；
 - 4) 结论归纳。
- 五、测试结果：

启用工具 success=True chars=1363 markers=20

禁用工具 success=True chars=628 markers=12

工具说明：tool_风险洞察:tool_风险洞察：从长者智能计算图提取历史参考证据
tool_个性化健康档案:tool_个性化健康档案：从长者智能计算图提取历史参考证据
tool_体征洞察:tool_体征洞察：从长者智能计算图提取历史参考证据
tool_用药洞察:tool_用药洞察：从长者智能计算图提取历史参考证据
tool_健康评估记录:tool_健康评估记录：从长者智能计算图提取历史参考证据
tool_风险照护联动:tool_风险照护联动：从长者智能计算图提取历史参考证据

六、结论：工具可显著提升智能体输出准确性、完整性与专业性，助力机构提供更精准照护与医疗服务。

【启用工具输出摘录】

BPSD 事件处理建议

长者姓名：陈萍忠
事件时间：今日上午
事件类型：拒绝参与康复活动，情绪沉默
报告人：照护员

一、处置等级

轻度BPSD事件。表现为退缩性行为（沉默、拒绝配合），无攻击、自伤、游走或激越，现场安全风险为中低，生命体征平稳。

二、继续观察条件

可继续观察，若同时满足以下条件：

- 24小时内未再次发生同类拒绝行为；
- 无新发躯体不适（如疼痛、发热、呕吐、腹泻）；
- 情绪保持平稳，未出现哭闹、攻击、夜间游走等行为；
- 日常生活参与度未进一步下降。

三、护士介入条件

已满足介入条件（护士已通知）。建议护士执行以下措施：

1. **为家属提供照护指导**：解释失智老人沉默退缩行为的常见原因，指导非对抗性沟通技巧，缓解家属中高焦虑；
 2. **评估潜在躯体不适**：排查是否存在颈部僵硬、关节疼痛或其他隐匿性不适，可能导致其拒绝舞蹈类活动；
 3. **优化非药物干预方案**：建议暂停当前舞蹈训练，尝试更温和、个体化的活动（如音乐聆听、简单手工、庭院散步）；
 4. **记录行为日志**：详细记录每次拒绝行为的时间、前驱事件、环境因素及缓解方式，用于后续干预调整。
-

四、GP介入条件

当前未达到GP介入标准。

根据预设升级阈值，仅当出现以下任一情况时需通知GP：

- 24小时内同类事件复发 ≥ 2 次；
- 出现攻击行为、自伤、走失或跌倒；
- 新发明明显躯体症状（如持续腹痛、发热、意识改变）。

目前事件为单次、短暂（10分钟）、可安抚，且无上述高风险表现，**暂无需GP会诊**。

五、后续观察重点

1. **行为节律**：过去7天3次事件均发生于上午10 – 11点，需关注是否与生物节律、晨间药物作用或疲劳相关；
 2. **情绪演变**：警惕从退缩向激越或淡漠加重转变；
 3. **躯体健康**：结合历史存在皮肤损伤、胃肠事件及心率偏低，需监测有无感染、出血倾向或循环不稳定迹象；
 4. **心率动态**：虽当前60次/分属正常范围，但结合起搏器植入史及历史数据，建议增加日间多时段心率、血压监测；
 5. **家属心理状态**：持续提供支持，避免因焦虑导致过度干预或负面互动。
-

六、升级流程是否触发

否。本次事件未触发预设升级流程。

理由：单次、短暂、无安全威胁，且未达24小时内复发 ≥ 2 次或出现高风险行为的阈值。

七、综合建议

尽管本次事件无需升级，但鉴于**近一周内已发生3次类似行为**，提示当前康复干预方案可能与老人当前状态不匹配。建议：

【禁用工具输出摘录】

《BPSD 事件处理建议》

处置等级：轻度（常规照护干预层级）

继续观察条件：

- 事件未在24小时内重复发生 ≥ 2 次；
- 未出现攻击行为、自伤、走失、跌倒等高风险表现；
- 情绪沉默或拒绝配合持续时间 ≤ 15 分钟，且可通过非药物安抚缓解。

护士介入条件： 已满足（护士已通知）

建议护士执行以下措施：

1. 对照护团队提供认知干预优化建议：调整上午康复活动形式，避免强制参与，采用兴趣引导式或一对一温和互动；
2. 为家属提供现场照护指导，解释沉默抗拒在阿尔茨海默病中的常见性，降低其焦虑预期；
3. 记录本次事件详细情境（活动内容、环境、照护员回应方式），用于识别潜在诱因。

GP介入条件： 未满足

当前无精神病症状、激越、躯体不适或用药相关不良反应迹象，暂无需全科医生介入。

后续观察重点：

- 上午10:00 – 11:00时段的行为模式变化；
- 拒绝行为是否与特定活动、人员或环境因素关联；
- 家属焦虑水平对老人情绪的影响；
- 未来24小时内是否再次发生类似或更严重事件。

升级流程是否触发：否

理由：本次为24小时内首次发作，无攻击、走失、跌倒等高风险行为，未达到预设升级阈值（24h内 ≥ 2 次或出现高风险行为）。

*注：本建议基于当前实时报告信息生成，历史图谱数据未调用，符合“优先最新输入”原则。

*